

SISTEMA EPIDEMIOLOGICO ITALIA

Report clinico-statistico sulle principali patologie autoimmuni monitorate in Italia

Documento generato automaticamente dal modulo riservato al Ricercatore Clinico | Data: 30/06/2026 |
Ora: 16:02

1. REPORT

Il presente report sintetizza i risultati principali emersi dall'analisi del database epidemiologico relativo a 5 patologie autoimmuni monitorate sul territorio nazionale. L'elaborazione è stata eseguita in ambiente MATLAB a partire da dati strutturati in formato CSV, con l'obiettivo di integrare consultazione descrittiva, confronto clinico e supporto all'interpretazione epidemiologica. Nel campione analizzato risultano complessivamente 9775104 casi registrati. La patologia con il maggior carico osservato nel dataset è "Tiroidite di Hashimoto", che da sola rappresenta il 43.6% del totale considerato. La mortalità/letalità media osservata nel dataset è pari al 0.14%, con una stima complessiva di circa 8228 decessi calcolata sui valori disponibili.

2. INDICATORI CHIAVE DEL DATASET

- Patologie monitorate: 5
- Casi complessivi analizzati: 9775104
- Patologia a maggiore prevalenza nel dataset: Tiroidite di Hashimoto (4261704 casi)
- Area/regione con maggior numero di casi registrati: Lombardia (1586291 casi)
- Numero di regioni/aree monitorate nel dataset: 20
- Mortalità/letalità media osservata: 0.14%
- Decessi stimati complessivi (calcolo su base percentuale): 8228
- Variabilità tra patologie (dispersione dei casi): 1466248.85

3. GRADUATORIA DI PREVALENZA DELLE PATOLOGIE

La seguente graduatoria ordina le patologie in base al numero complessivo di casi registrati nel dataset. Tale classifica permette di identificare il peso relativo di ciascuna condizione all'interno del sistema epidemiologico analizzato.

- 1) Tiroidite di Hashimoto - 4261704 casi (43.6% del totale)**
- 2) Diabete Tipo 1 - 2145735 casi (22.0% del totale)
- 3) Celiachia - 1948844 casi (19.9% del totale)
- 4) Sclerosi Multipla - 973281 casi (10.0% del totale)
- 5) Morbo di Crohn - 445540 casi (4.6% del totale)

4. TABELLA DI SINTESI CLINICO-EPIDEMIOLOGICA

Patologia	Casi Totali	Quota % sul totale	Mortalità media %
Celiachia	1948844	19.9	0.02
Diabete Tipo 1	2145735	22.0	0.09
Morbo di Crohn	445540	4.6	0.06
Sclerosi Multipla	973281	10.0	0.50
Tiroidite di Hashimoto	4261704	43.6	0.02

5. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

L'analisi mette in evidenza una distribuzione non uniforme del carico epidemiologico tra le 5 patologie considerate. In particolare, Tiroidite di Hashimoto emerge come la condizione con il maggior numero di casi, rappresentando il 43.6% del totale osservato. Questo dato suggerisce che, all'interno del dataset utilizzato, tale patologia eserciti un peso sanitario più marcato rispetto alle altre condizioni monitorate. Dal punto di vista territoriale, la concentrazione massima di casi risulta associata a Lombardia, informazione che può essere utile per evidenziare possibili differenze regionali nella diagnosi, nella presa in carico o nella distribuzione della popolazione osservata. La presenza di un indicatore di mortalità/letalità permette inoltre di affiancare alla semplice prevalenza una valutazione, seppur sintetica, della severità clinica media del campione. In un contesto reale, un'integrazione di questo tipo sarebbe utile per orientare la programmazione sanitaria, la prioritizzazione delle risorse e la definizione di strategie di monitoraggio.

6. CONCLUSIONI E VALORE DEL SISTEMA

Il progetto "Sistema Epidemiologico Italia" è stato concepito come strumento integrato di consultazione e supporto decisionale, capace di coniugare visualizzazione interattiva, analisi quantitativa e sintesi documentale. La distinzione tra accesso Guest e accesso Ricercatore Clinico consente di separare la fruizione divulgativa dalla consultazione avanzata, rendendo la piattaforma adatta sia a finalità informative sia a contesti accademici e di studio. Dal punto di vista metodologico, l'uso di file CSV strutturati e di funzioni MATLAB dedicate alla lettura, aggregazione e rappresentazione dei dati permette di costruire un flusso di lavoro replicabile, estendibile e coerente con un'impostazione di analisi epidemiologica. Il report PDF costituisce il livello conclusivo del progetto, trasformando i risultati numerici in un documento sintetico, leggibile e professionale.

Nota: i risultati riportati dipendono dalla struttura e dall'aggiornamento del file CSV caricato nel database. Il report ha finalità didattiche e di analisi del dato e non sostituisce un documento clinico ufficiale.